PODEJRZENIE BŁĘDU DIAGNOSTYCZNEGO W STOMATOLOGII — PORADNIK PRAWNO-PRAKTYCZNY

Stan prawny sprawdzony: 13.10.2026. Materiał ma charakter informacyjny. Nie przesądza, czy w konkretnym przypadku doszło do błędu, i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej ani medycznej.

1. Najpierw ustal, co wiadomo, a co wymaga dowodu

W sprawie nawrotu torbieli po wcześniejszej operacji kluczowe nie jest samo to, że na późniejszym CBCT stwierdzono zmianę. Trzeba ustalić:

1. czy zmiana była już widoczna na wcześniejszym badaniu;
2. czy zgodne z aktualną wiedzą postępowanie wymagało wtedy dalszej diagnostyki lub leczenia;
3. czy opóźnienie rozpoznania spowodowało szkodę albo zwiększyło jej rozmiar, dolegliwości lub koszty.

Porównanie oryginalnych badań obrazowych z datami może być ważnym dowodem. Ustalenie przyczynowości i standardu leczenia zależy jednak od pełnej dokumentacji oraz oceny medycznej. Nie należy przedstawiać podejrzenia jako potwierdzonego błędu przed uzyskaniem takich dowodów.

Jeśli potrzebne jest pilne leczenie, nie należy go odkładać z powodu zbierania dokumentów lub opinii.

2. Jak zabezpieczyć dokumentację

Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia i udzielonych świadczeń. Dokumentacja może być udostępniona m.in. jako kopia, wydruk, elektronicznie lub na informatycznym nośniku danych. Pierwsze udostępnienie w żądanym zakresie i ustawowo wskazanych formach jest bezpłatne. Ustawowy standard to udostępnienie bez zbędnej zwłoki — nie ma ogólnego terminu 14 dni roboczych na wydanie dokumentacji. Ustawa o prawach pacjenta, art. 23–28

W przypadku badania CBCT warto poprosić o dostępne pliki źródłowe, opisy i wpisy z wizyt. Przekazywać należy oryginalne pliki bez ich modyfikowania i zachować kopię zapasową. Wnioskiem o dokumentację można żądać materiałów, które placówka już prowadzi lub posiada. Nowa opinia porównawcza jest odrębną konsultacją, a nie dokumentem, który placówka musi wytworzyć w ramach prawa dostępu do dokumentacji.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, na wniosek pacjenta, udziela niezbędnych informacji o umowach ubezpieczenia, o których mowa w art. 25 ustawy o działalności leczniczej. Warto poprosić o nazwę ubezpieczyciela, numer i okres polisy oraz sumę gwarancyjną. Ustawa nie wyznacza ogólnego 7-dniowego terminu na odpowiedź na ten wniosek; siedem dni można wskazać jako własny, proponowany termin. Ustawa o działalności leczniczej, art. 14 i 25

3. Jak przygotować porównanie badań

Przy prośbie o ocenę porównawczą dostarcz specjaliście, o ile są dostępne:

- oryginalne CBCT z wizyty spornej;
- CBCT wykonane później, gdy rozpoznano zmianę;
- wcześniejsze badanie kontrolne, np. z 2023 r.;
- opisy i dokumentację kliniczną z tych wizyt.

Warto poprosić o odpowiedź na konkretne pytania: czy zmiana była widoczna na wcześniejszym obrazie, jakie postępowanie było wtedy wskazane i czy późniejsza interwencja lub dodatkowe koszty mogły być następstwem opóźnienia. Opinia jednego lekarza może pomóc w ocenie i zgłoszeniu sprawy; w sporze sądowym znaczenie dowodów ocenia sąd, który może korzystać z opinii biegłego.

4. Możliwe podstawy odpowiedzialności i roszczenia

Lekarz ma wykonywać zawód zgodnie z aktualną wiedzą, dostępnymi metodami i należytą starannością. Odpowiedzialność cywilna wymaga jednak wykazania przesłanek właściwych dla danej podstawy prawnej, w tym szkody i związku przyczynowego. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 8 · Kodeks cywilny, m.in. art. 415, 430, 444–445 i 822

- **Koszty leczenia:** art. 444 § 1 KC obejmuje koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Na żądanie może obejmować także wyłożenie z góry sumy potrzebnej na leczenie.
- **Zadośćuczynienie:** art. 445 § 1 KC dotyczy krzywdy, w tym cierpień fizycznych i psychicznych; wysokość zależy od okoliczności i dowodów.
- **Bezpośrednie roszczenie wobec ubezpieczyciela:** art. 822 § 4 KC pozwala dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela OC, gdy zdarzenie jest objęte umową.
- **Odpowiedzialność placówki:** art. 430 KC może mieć zastosowanie, gdy spełnione są jego przesłanki, w szczególności relacja powierzenia czynności i podlegania kierownictwu. Nie wynika automatycznie z samego faktu, że lekarz przyjmował w danej placówce. Należy ustalić formę praktyki i relacje między podmiotami.

Nie każdy koszt późniejszego leczenia można bez dalszej analizy przypisać wcześniejszej kontroli. Jeśli samo rozpoznanie nawrotu wymagałoby zabiegu niezależnie od opóźnienia, trzeba osobno ocenić, czy opóźnienie zwiększyło zakres leczenia, koszty, ból lub inne następstwa.

5. Zgłoszenie szkody i terminy ubezpieczyciela

Zgłoszenie do ubezpieczyciela powinno zawierać jasną chronologię, opis roszczeń i dostępne dowody. Kwoty warto rozdzielić na wydatki już poniesione, uzasadnione koszty przyszłego leczenia oraz zadośćuczynienie. Należy podać tylko rzeczywiście występujące objawy i udokumentowane lub możliwe do wykazania koszty.

Art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje zasadniczo 30 dni na wypłatę odszkodowania

od zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w tym terminie nie można wyjaśnić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, ustawa określa dalszy termin — co do zasady 14 dni od chwili, gdy wyjaśnienie stało się możliwe, z limitem 90 dni od zgłoszenia i ustawowymi wyjątkami. W terminie podstawowym wypłaca się część bezsporną. Nie jest to gwarancja wypłaty całej żądanej kwoty w ciągu 30 dni. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, art. 14

Zgłoszenie roszczenia lub zdarzenia ubezpieczycielowi może przerwać bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie wobec tego ubezpieczyciela na zasadach z art. 819 § 4 KC. Nie należy zakładać, że wywołuje taki sam skutek wobec lekarza lub placówki.

6. Przedawnienie i przyczynienie

Nie należy przyjmować jednej automatycznej daty początku przedawnienia. Art. 442^1 KC wiąże bieg terminu m.in. z wiedzą o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia; zastosowanie przepisu zależy od rodzaju roszczenia i konkretnych okoliczności. Datę warto ocenić indywidualnie, zwłaszcza przed upływem czasu.

Wcześniejsze objawy lub przerwa w szukaniu pomocy mogą być istotne dla oceny przebiegu i związku przyczynowego. Nie oznacza to automatycznie przyczynienia w rozumieniu art. 362 KC ani automatycznej utraty roszczenia. Opisuj chronologię zgodnie z prawdą i zostaw ocenę jej skutków dla konkretnej sprawy.

7. Kolejność działania

1. Kontynuuj potrzebne leczenie i zbieraj dokumenty dotyczące jego przebiegu.
2. Wystąp do każdej placówki osobno o dokumentację i pliki badań.
3. Poproś o dane ubezpieczyciela podmiotu/lekarza, którego dotyczy wizyta.
4. Uporządkuj chronologię, dowody objawów i rachunki.
5. Zorganizuj porównawczą ocenę CBCT oraz pisemny plan i kosztorys leczenia.
6. Zgłoś szkodę z ostrożnie sformułowanym opisem zarzutu; uzupełniaj materiał po uzyskaniu dokumentów.
7. Zachowaj potwierdzenia wysłania i wszystkie odpowiedzi. W razie odmowy rozważ reklamację u ubezpieczyciela, wsparcie Rzecznika Finansowego lub indywidualną konsultację prawną.

Powiązane materiały

- Poradnik sprawy — strona HTML
- Plan postępowania — lista zadań
- Wniosek o dokumentację i informacje o OC
- Ogólny szablon zgłoszenia szkody
- Robocze zgłoszenie dotyczące tej sprawy